ONEMA-POP-061 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Avaliação de Ferida Crônica de Difícil Cicatrização e Suspeita de

Biofilme

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de avaliação de ferida crônica de difícil cicatrização e

suspeita de biofilme, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição,

avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

EPIs, régua de feridas, material de fotografia com consentimento, kit de avaliação vascular. Equipamentos

profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita

presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Analisar duração, etiologia, perfusão, diabetes, pressão, edema, exsudato e resposta prévia. Confirmar identificação,

consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar histórico e fatores que dificultam cicatrização, inclusive perfusão e glicemia.

02. Medir comprimento, largura, profundidade quando segura e evolução fotográfica consentida.

03. Avaliar tecido, bordas, pele perilesional, odor, exsudato e sinais de infecção clínica.

04. Considerar biofilme como hipótese clínica, não como diagnóstico visual definitivo.

05. Revisar causas subjacentes e necessidade de avaliação vascular ou especializada.

06. Realizar limpeza e cobertura conforme plano e perfusão; evitar desbridamento sem avaliação vascular quando indicado.

07. Estabelecer medidas de resposta e data de reavaliação; encaminhar se estagnação ou deterioração.

08. Registrar medidas seriadas, hipótese, plano, condutas e encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Isquemia, infecção sistêmica, necrose progressiva, dor desproporcional: encaminhamento urgente. Na emergência, acionar

SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar adesão à redução de pressão, controle de edema ou medidas etiológicas conforme diagnóstico.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

IWGDF/IDSA 2023 diabetic foot infection; Wound Healing Society guidelines (edição específica a conferir) | Conferir

aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.